



- frühzeitig
- parallel
- interprofessionell
- standardisiert

Palliative Geriatrie im AltersTraumaZentrum

Claudia Bamming, B. A.

FH Münster, Department of Health, Studiengang Palliativ Care M. A.

Problemhintergrund

Geriatrische Patient*innen (≥ 70 Jahre) sind durch Multimorbidität und vorbestehende Gebrechlichkeit (Frailty) charakterisiert [1]. Mit zunehmendem Alter (≥ 80 Jahre) steigt ihr Anteil an Krankenhausbehandlungen bei gleichzeitig längeren Verweildauern deutlich [12]. Treten alterstraumatologische Verletzungen bei ausgeprägter Frailty auf, versterben bis zu 36 % der Patientinnen innerhalb von 12 Monaten, und rund 30 % werden binnen 6 Monaten erstmals pflegebedürftig [7]. In Alterstraumazentren (ATZ) verbessern standardisierte Prozesse (Standard Operating Procedures, SOP) sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit die Prognose dieser Gruppe [7]. Unter „Palliativer Geriatrie“ wird ein ganzheitlicher, interprofessioneller Betreuungsansatz für multimorbide, hochbetagte Menschen bei fortschreitendem Funktionsverlust verstanden [3]. Hochaltrige, nichtonkologische Patient*innen weisen komplexe medizinische und pflegerische Bedürfnisse auf und sind im Krankenhaus palliativmedizinisch unterversorgt: Nur 17,8 % der Krankenhäuser verfügen über eine Palliativstation [8], über 80 % der dort Behandelten haben eine onkologische Grunderkrankung [8], obwohl nur 22,9 % aller Todesfälle in Deutschland [11] onkologisch sind. Bei begrenzter Prognose erhalten sie häufig weiterhin intensivmedizinische bzw. kurativ ausgerichtete Behandlungen. Dies erhöht das Risiko einer Übertherapie im Sinne eines nicht mehr realisierbaren Therapieziels [6]. Die Zertifizierungskriterien der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie für Alterstraumazentren [2] fordern ein strukturiertes geriatrisches Screening inklusive Frailty-Score (z.B. Clinical Frailty Score) und empfehlen die Einbindung von Palliativkonzepten in das perioperative Behandlungsmanagement. Im ATZ des Universitätsklinikums Münster existiert derzeit keine SOP, die eine systematische Identifikation und Versorgung geriatrischer Patient*innen mit palliativen Bedarfen gewährleistet.

Ziel

Wie kann eine SOP zur systematischen **Identifikation** und **Versorgung** geriatrischer Patient*innen mit palliativem Bedarf im ATZ entwickelt und im klinischen Alltag implementiert werden?

Methode

- Literaturrecherche in PubMed zu Frailty- und Palliativ-Screening-Instrumenten bei geriatrischen Patient*innen im Krankenhaus.
- Ableitung eines Screening-Bundles und Konzeption eines SOP-gestützten Behandlungspfads für das ATZ.
- Integration des im ATZ routinemäßig erhobenen CFS als Auslöser für den Palliativpfad.

Stand der Forschung

- Frailty (CFS) ist ein starker Mortalitätsprädiktor, erfasst aber aufgrund des schleichenden Krankheitsverlaufs keine spezifischen palliativen Bedarfe [5].
- Frailty-spezifische, bedarfsorientierte Assessments bei nicht-onkologischen, frailen Patient*innen fehlen [9].
- Das Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT-DETM) zeigt gute Sensitivität im Krankenhaus. Es wird ergänzend empfohlen [4,5].
- Die Surprise Question (SQ) zeigt bei Frailty nur eingeschränkte Vorhersagekraft, wird ergänzend innerhalb anderer Instrumente empfohlen [4,5].

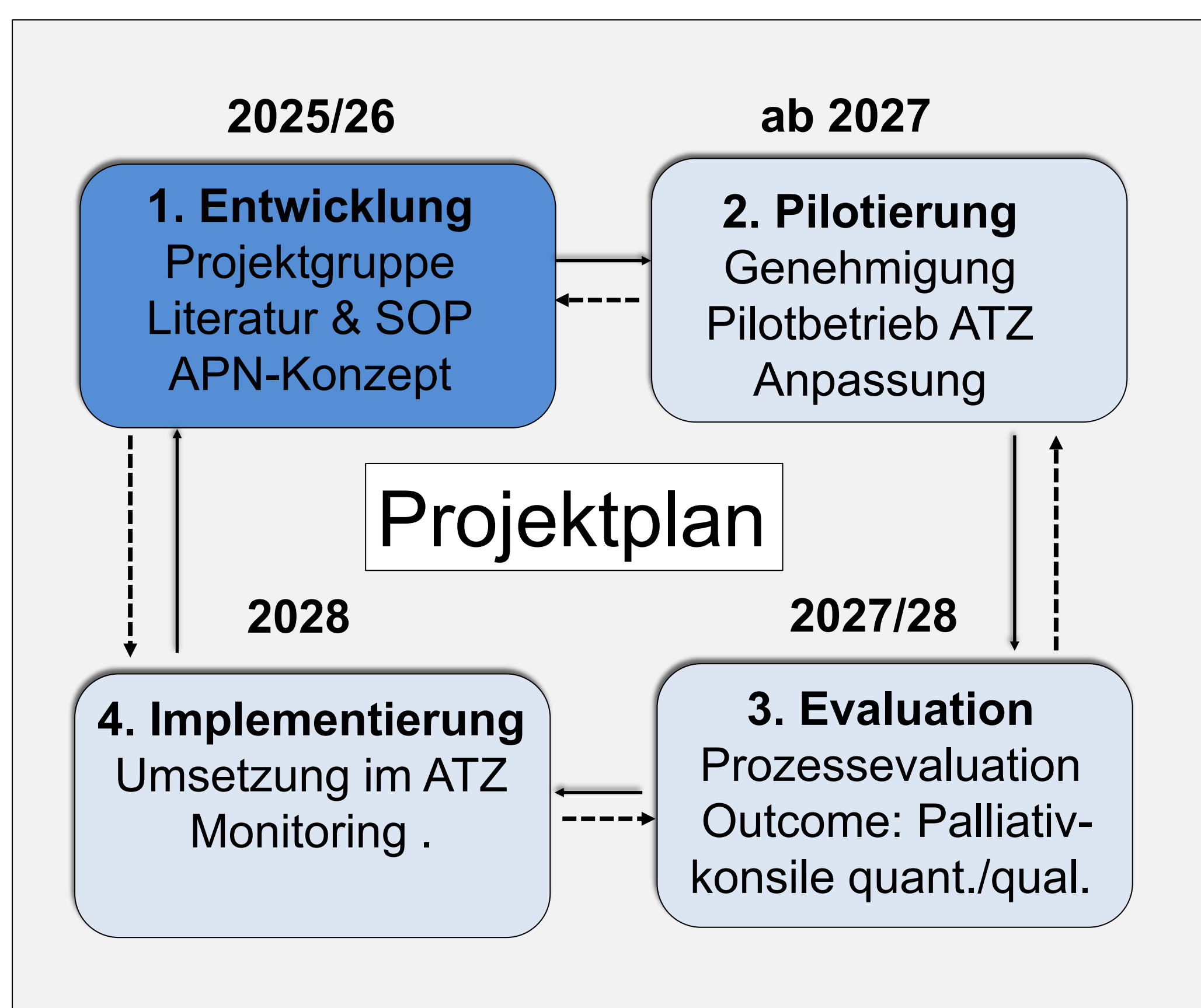


Abb. 2: Projektplan, angelehnt an das MRC-Framework [10]
iterativ – Rücksprünge je Phase möglich

Geplante Intervention: SOP-Palliativpfad im ATZ

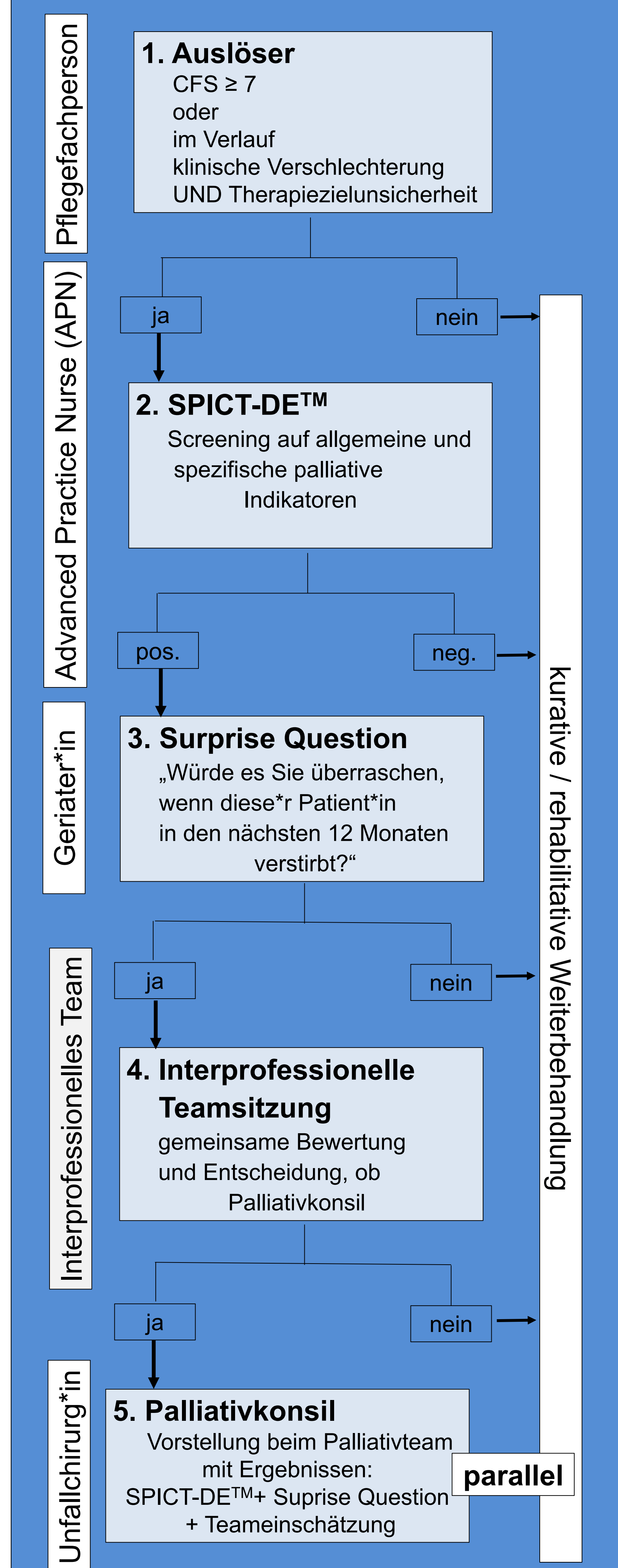


Abb. 3: Geplanter SOP-Palliativpfad zur Identifikation von geriatrischen Patient*innen mit palliativem Bedarf

Bausteine der palliativ orientierten Versorgung im ATZ

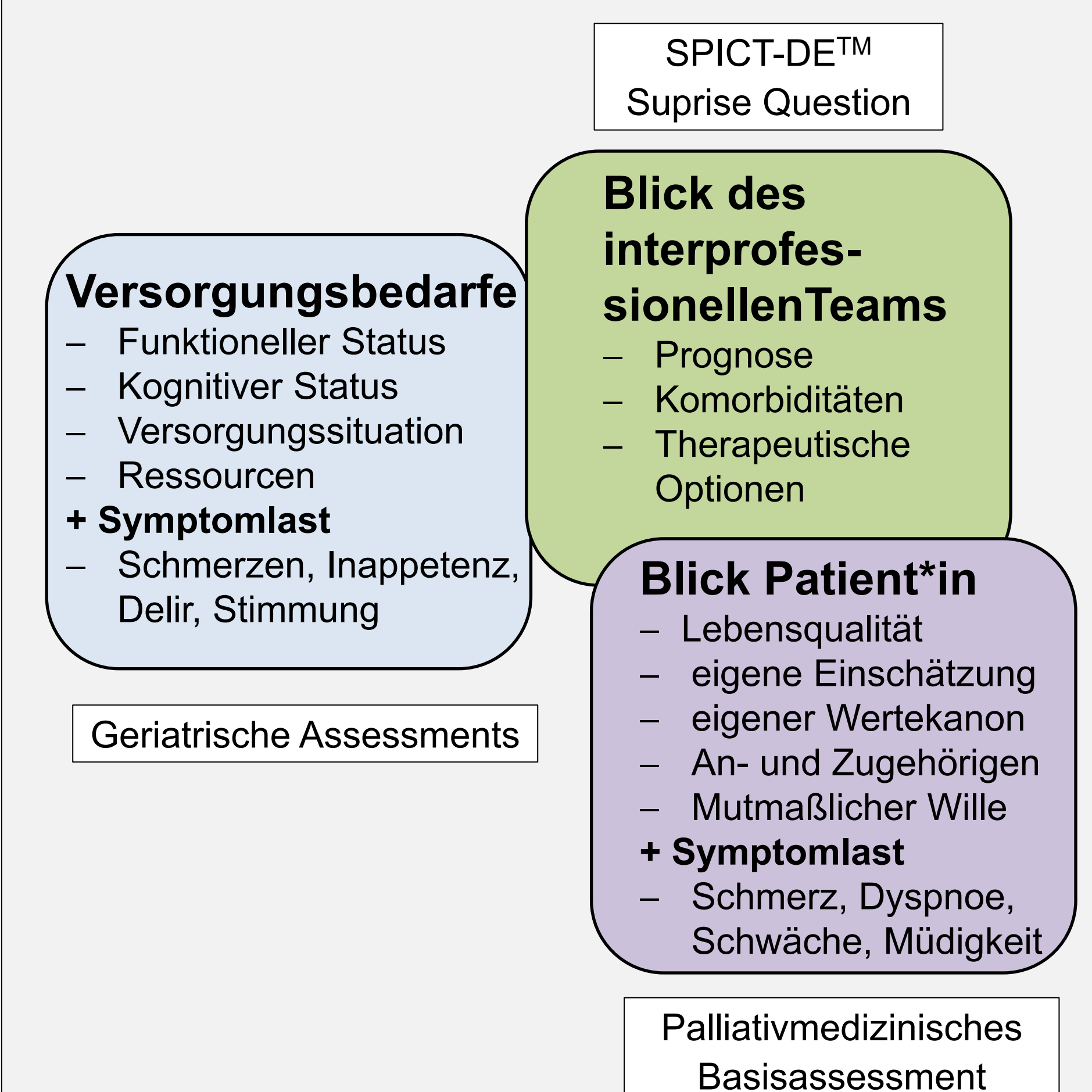


Abb. 4: Bausteine der palliativen Versorgung geriatrischer Patient*innen

Ressourcen/Herausforderungen

Der geplante SOP-Pfad ist bislang nicht validiert. Definierte Outcome-Parameter zur Wirksamkeitsprüfung stehen noch aus. Bislang identifizierte:

Ressourcen	Herausforderungen
Vorhandene SOP-Strukturen im ATZ und in der Palliativmedizin	Begrenzte palliativmedizinische Qualifikation im Team
Aufbau Rolle APN führt zur Kompetenzerweiterung im Team und fördert das Schnittstellenmanagement	„bottom up“ Projekt – hierarchische und interdisziplinäre Zustimmung notwendig
Unterstützung durch Pflegewissenschaft	Kurativ geprägtes Mindset im Team

Fazit

Die Entwicklung einer SOP mit früher palliativgeriatrischer Einbindung soll eine multiprofessionelle, präventive Therapiezielfindung unterstützen, in der kurative, rehabilitative und palliative Maßnahmen parallel am Patient*innenwillen ausgerichtet werden.